

Acute On Chronic Liver Failure (ACLF)

Lucas de O. Araujo
Médico Intensivista Diarista
da Unidade de Gastroenterologia do HCFMUSP



Caso Clínico

PH, 50 anos, cirrose OH
identificada por exames
de rotina

5 anos



Há 1 mês notou aumento do
volume abdominal
Admitido com HDA varicosa
Admitido com Hb 4 com
hematêmese
Recebeu IOT para proteção de
vias aéreas
Desenvolveu sinais de má
perfusão e necessidade de DVA
0.5 mcg/kg/min
Recebeu terapia com ligadura
elástica sem ressangramento
Encaminhado a UTI

3 dias



Evoluiu com necessidade de TRS
INR 4 BT 15
IOT-VM sem sedanalgesia ECG 6T
Mantido noradrenalina 0.4 mcg/kg/min
Não recorreu a sangramentos, sem
nova queda de Hb
Rastreio infeccioso negativo, em uso de
Meropenem
**A despeito dos esforços da equipe,
evolui a óbito**



Evolução da Doença Hepática

Stages of chronic liver disease	No cirrhosis	Compensated cirrhosis		Decompensated cirrhosis	
		Lower risk of decompensation	Higher risk of decompensation	First decompensation	Further decompensation
Clinical features (ascites, VH or HE)	None	None	None	One event	>1 event or complication of event*
Histological diagnosis	F0-F2	F3/F4 (thin septa)	F4 (thick septa)	Clinical	Clinical
Hemodynamic features (HVPG mmHg)	3-5	5-10	>10 (CSPH)	>20 worse outcomes in VH	>20 worse outcomes in VH
Endoscopic features	None	No varices	± Varices	± Varices	± Varices

Risk of death

Hepatology.
2024;79:1180–1211



Aprendendo a diferenciar as entidades...

DESCOMPENSAÇÃO
AGUDA DA CIRROSE



Insuficiencia Hepatica
Cronica Agudizada
(ACLF)

Ascite

Varizes
Hemorrágicas

Encefalopatia
Hepática

Infecções

Insuficiência
Hepática

Disfunções
Extrahepáticas

Hepática, renal, neurológica, imune, gastrintestinal, pulmonar,
adrenal, muscular e tireoidiana...

MORTALIDADE EM CURTO PRAZO



Abrangência de Disfunções de Acordo com Definição

	Organ	APASL ACLF Research Consortium	EASL CLIF-C ACLF	NACSELD
	Liver	Total Bilirubin PT/INR	Total bilirubin PT/INR	--
	Kidney	Creatinine	Creatinine/Dialysis	Dialysis
	Brain	HE grade	HE grade	HE grade III/IV
	Circulatory	Lactate	MAP, vasopressors	MAP, vasopressors
	Respiratory	--	PaO ₂ or SpO ₂ / FiO ₂	Mechanical ventilation
	Major Organ failure Category	Predominantly Hepatic failure variables	Combination of hepatic and extrahepatic organ failure variables	Predominantly extrahepatic organ failure variables

Am J Gastroenterol 2022;117:225–252



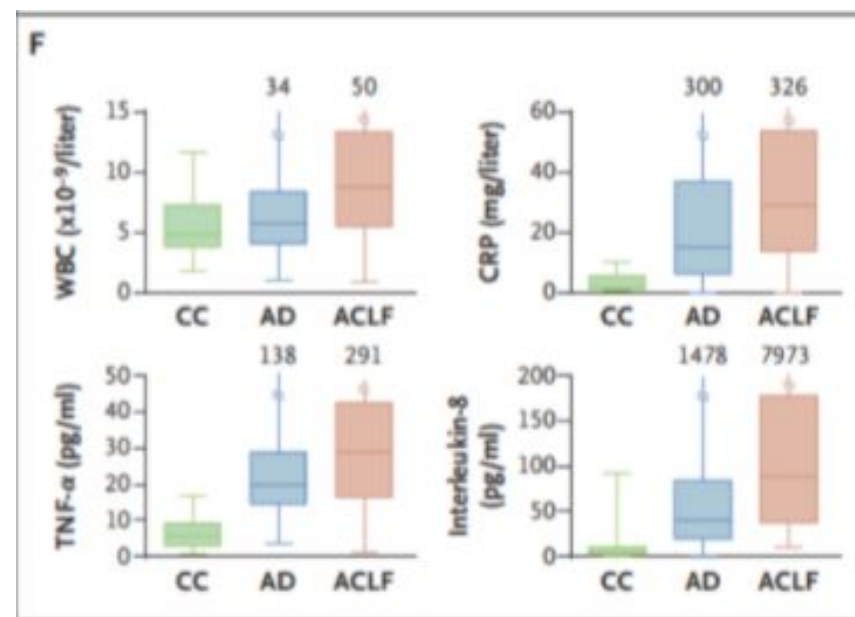
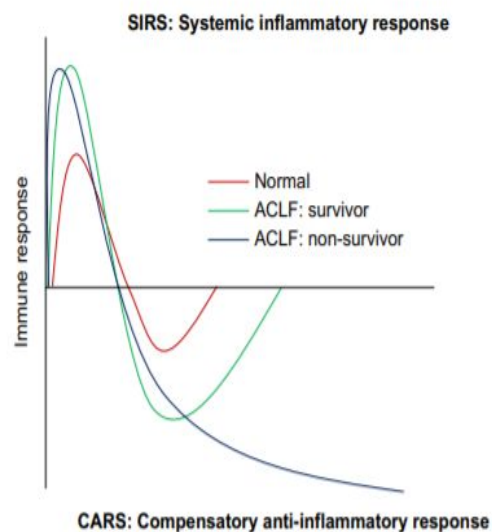
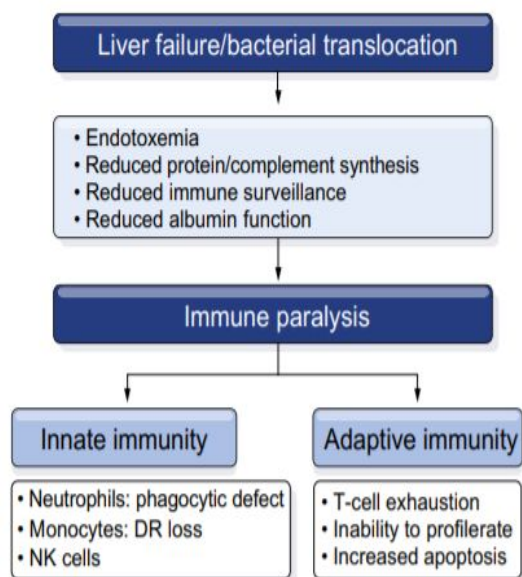
Definições ACLF

World Gastroenterology Organization

1. Presença de cirrose hepática (com diagnóstico ou não)
2. Cirrose Descompensada
 - Alargamento de INR / icterícia E
 - Uma ou mais disfunções extrahepáticas
3. Aumento de mortalidade entre 28 dias - 3 meses desde o insulto

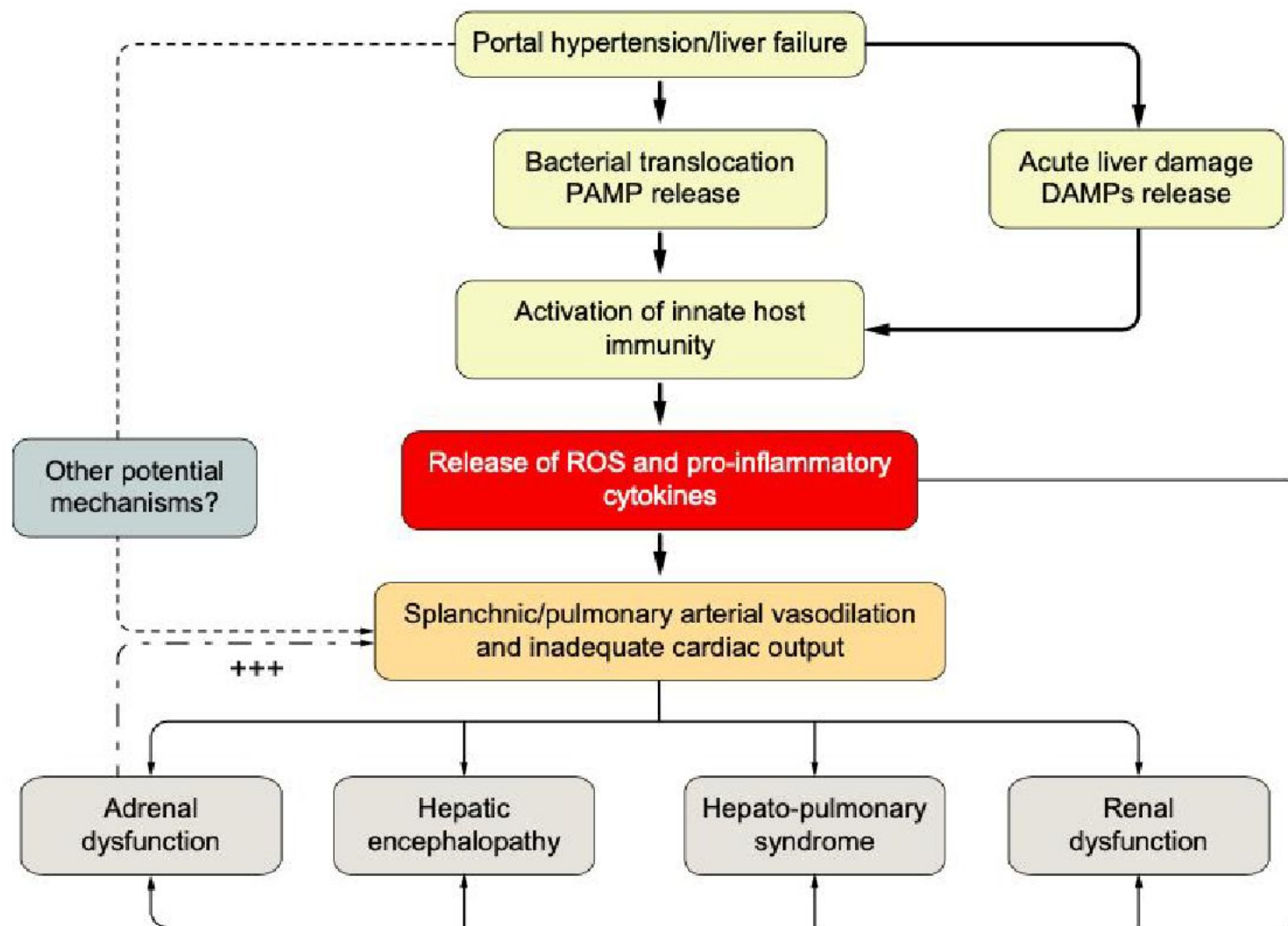


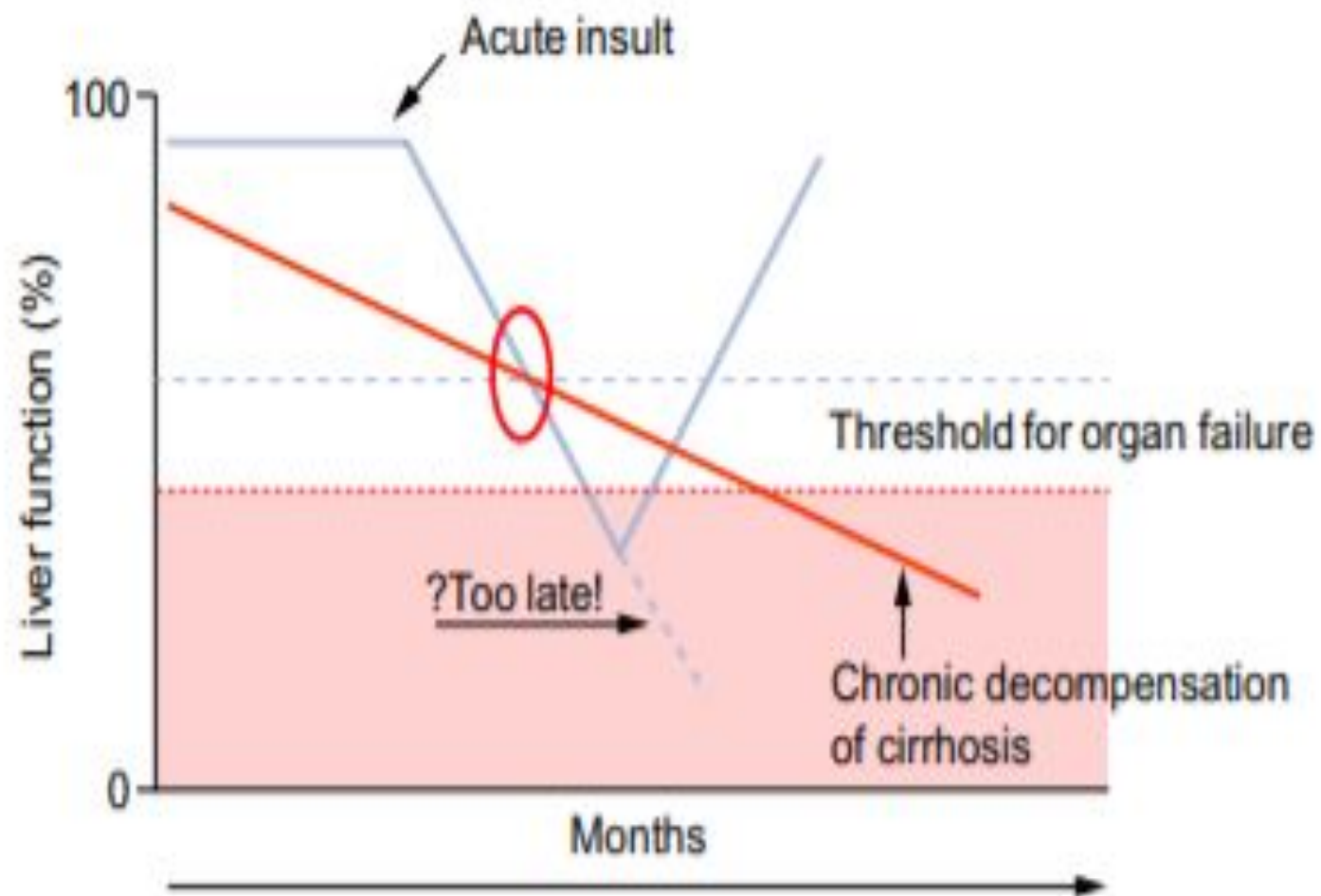
Disfunção Imune



Gastroenterology, 2013. doi: 10.1053/j.gastro.2013.02.042

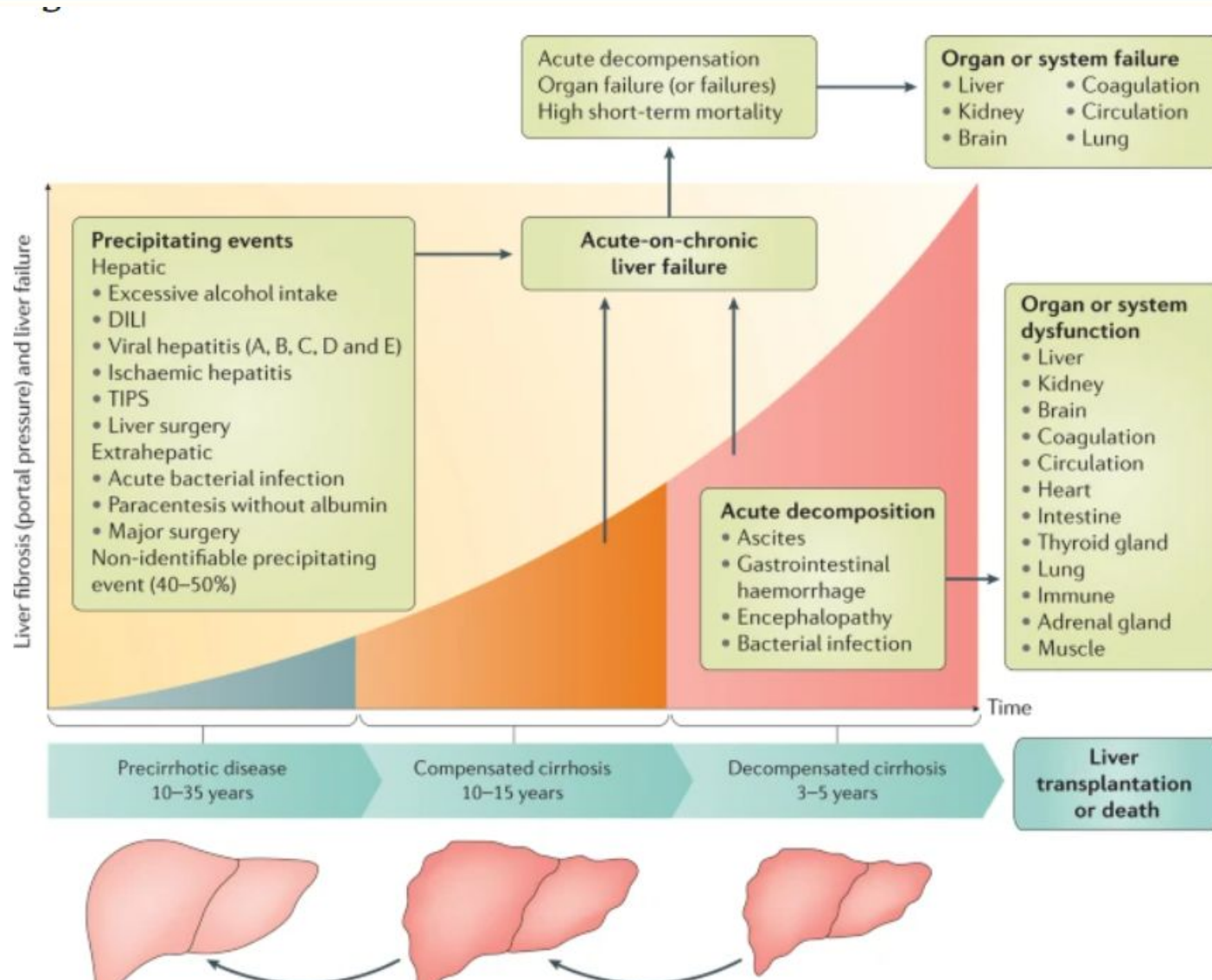






Jalan et al. *J Hepatol* 2012; 57 | 1336–1348





Eventos deflagrantes

Precipitating event	Patients without ACLF (%) (<i>n</i> = 1,040)	Patients with ACLF (%) (<i>n</i> = 303)	<i>P</i> value*
Bacterial infection	21.8	32.6	<0.0001
Gastrointestinal bleeding	17.3	13.2	NS
Active alcoholism [‡]	14.9	24.5	0.0002
Other event [§]	3.5	8.6	0.0002
No event	58.9	43.6	<0.0001
Any event	41.1	56.4	<0.0001
> 1 event	5.7	13.5	<0.0001

Gastroenterology. 2013 Jun;144(7):1426-37, 1437.e1-9



Fatores Precipitantes

Ocidente: alcoolismo ativo, infecções bacterianas e maior proporção de etiologia indefinida

Oriente: reativação de HBV, hepatite ou E agudas, hepatite alcóolica aguda e infecções bacterianas

Table 4 Reported triggers of acute-on-chronic liver failure, number (%)

	CANONIC n=303, (9)	Shi et al n=405, (14)
Exacerbation hepatitis B	—	145 (35.8)
Bacterial infection	98 (32.6)	113 (27.9)
GI haemorrhage	40 (13.2)	40 (9.8)
Active alcoholism within the past 3 months	69 (24.5)	25 (6.1)
Other (TIPSS, surgery, large volume paracentesis without albumin, hepatitis, alcoholic hepatitis)	25 (8.6)	9 (2)
Not identifiable	126 (43.6)	83 (20.4)
More than one	39 (13.5)	36 (8.9)

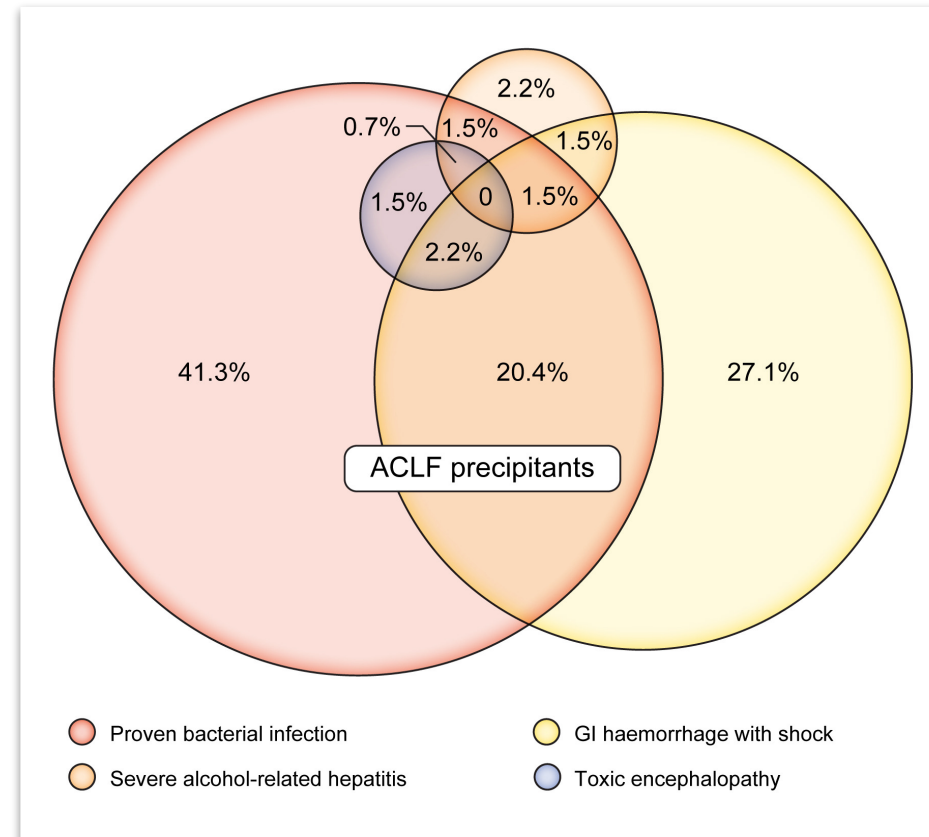
CANONIC, EASL-CLIF Acute-on-Chronic Liver Failure in Cirrhosis; TIPSS, transjugular intrahepatic portosystemic shunt.

Bernsmeier, C. et al. K. Gastroenterology (2015)
Moreau, R. et al. Gastroenterology (2013)
Hernaez R, et al. Gut 2017;66:541–553.



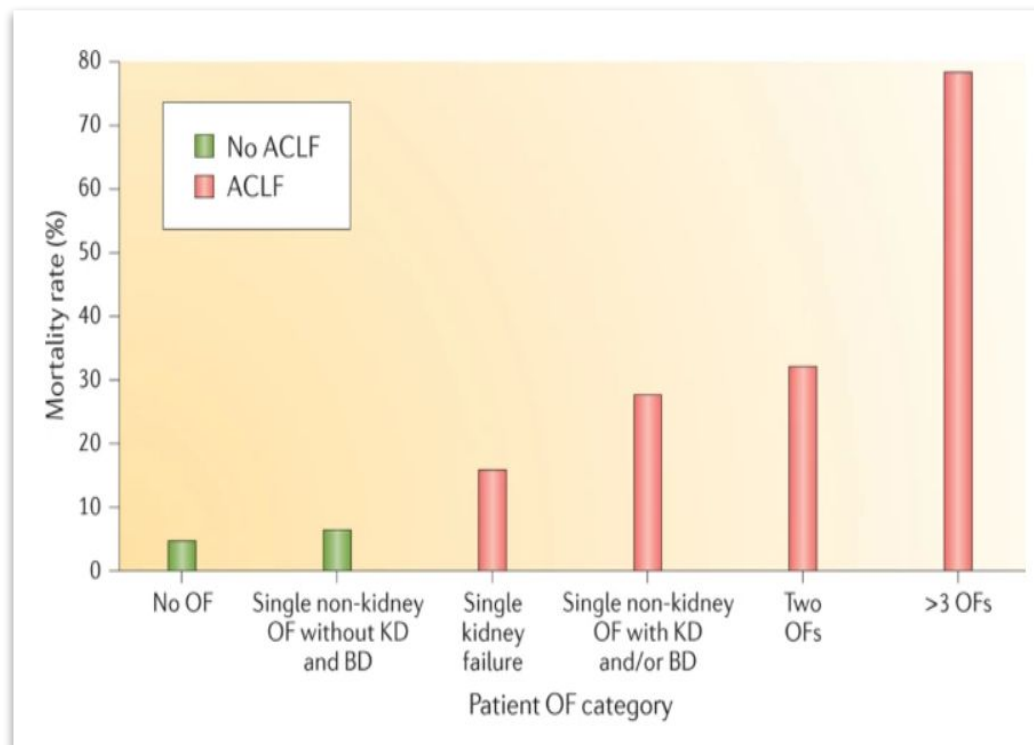
ESTUDO PREDICT

- Único estudo prospectivo desenhado para identificação de precipitantes
- 420 pacientes
 - 273: pelo menos 1
 - 147: nenhum
 - Até 3 precipitantes simultâneos
 - Mais frequente: hepatite alcoólica + infecção



Mortalidade em curto prazo - Estudo CANONIC

- Série de 1343 pacientes admitidos em 21 hospitais para tratamento de descompensação aguda
- Definido como mortalidade alta em curto prazo o valor > 15% (50% do observado em sepse grave na população geral)
- Incremento exponencial com 2-3 disfunções



[Nature Reviews Disease Primers](#) volume 2, Article number: 16041 (2016)



Paradoxo do ACLF - CANONIC

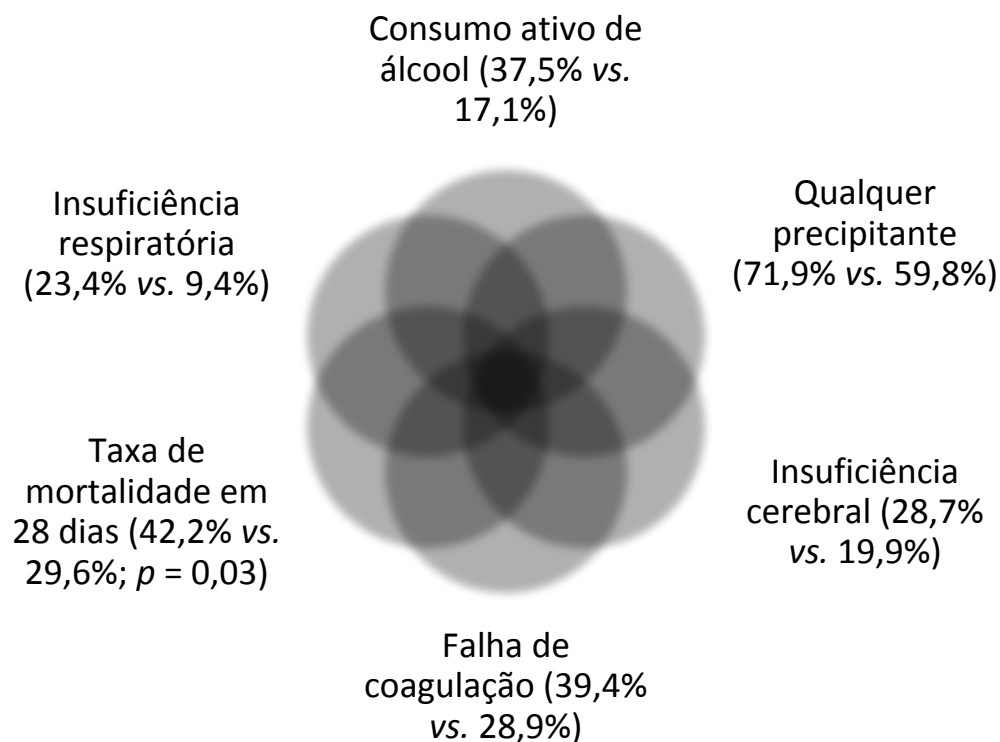
Pacientes sem descompensação prévia tiveram probabilidade significativamente maior de apresentar graus mais graves de ACLF (16,5%; 27,6% e 42,9% para graus 1, 2 e 3, respectivamente; $p < 0,01$)

Gastroenterology. 2013 Jun;144(7):1426-37, 1437.e1-9



Paradoxo do ACLF - CANONIC

Grupo sem descompensação prévia também apresentou maior ocorrência de:



Gastroenterology. 2013 Jun;144(7):1426-37, 1437.e1-9



Mortalidade em curto prazo - Estudo CANONIC

Número e tipo de falência de órgãos	Todos os pacientes	Sem disfunção renal ou cerebral	Disfunção renal ou cerebral
	Nº de pacientes falecidos/nº total. de pacientes (%)		
Sem falência de órgãos	39/874 (4,5)	20/562 (3,6)	19/312 (6,2)
Falência de um órgão	39/267 (14,6)	17/184 (9,2)	22/83 (26,5)
Insuficiência hepática	14/101 (13,9)	4/68 (5,9)	33/10 (30,3)
Insuficiência cerebral	30/03 (10,0)	25/02 (8,0)	1/5 (20,0)
Falha de coagulação	28/03 (10,7)	19/01 (5,3)	2/9 (22,2)
Circulação ou insuficiência pulmonar	22/03 (13,6)	1/15 (6,7)	2/7 (28,6)
Falência renal	16/86 (18,6)	9/57 (15,8)	29/07 (24,1)
Duas falências de órgãos	31/97 (32,0)	19/66 (28,8)	31/12 (38,7)
Falências de três órgãos ou mais	33/42 (78,6)	25/29 (86,2)	13/08 (61,5)

Gastroenterology. 2013 Jun;144(7):1426-37, 1437.e1-9



Critérios Diagnósticos - CLIF-SOFA/CLIF C-OF

Table 1. Chronic liver failure-sequential organ failure assessment (CLIF-SOFA) score.

System	0 Points	1 Point	2 Points	3 Points	4 Points
Bilirubin (mg/dl)	<1.2	1.2 to <2.0	2.0 to <6.0	6.0 to <12.0	≥12.0
Creatinine (mg/dl)	<1.2	1.2 to <2.0	2.0 to <3.5	3.5 to <5.0	≥5.0 or dialysis
Hepatic encephalopathy grade	0	1	2	3	4
International normalized ratio	<1.1	1.1 to <1.25	1.25 to <1.5	1.5 to <2.5	≥2.5 or platelet count <20 x 10 ⁹ /L
Mean arterial pressure (mmHg)	≥70	<70	Dopamine ≤5 or dobutamine or terlipressin	Dopamine >5 or epinephrine ≤0.1 or norepinephrine ≤0.1	Dopamine >15 or epinephrine >0.1 or norepinephrine >0.1
PaO ₂ /FiO ₂	>400	>300 to 400	>200 to 300	>100 to 200	≤100

Coloured areas indicate diagnostic criteria for organ failures.

FiO₂, fraction of inspired oxygen; PaO₂, partial pressure of arterial oxygen.



Acometimento por Sistema Orgânico

Prevalência:

- Renal (55.8%)
- Fígado (43.6%)
- Coagulação (27.7%)
- SNC (24.1%)
- Hemodinâmica (16.8%)
- Pulmonar (9.2%)



Fenótipos Clínicos

“Disfunção” orgânica X “Insuficiência” orgânica

Cirrose Descompensada sem ACLF

- Nenhuma insuficiência orgânica
- Disfunção isolada sem envolvimento renal com Cr < 1.5
- Disfunção neurológica com Cr < 1.5

ACLF grau 1

- Insuficiência renal isolada com Cr ≥ 2
- Insuficiência hepática, coagulação ou pulmonar que é associada com Cr 1.5-1.9 e/ou EH 1/2
- Falência neurológica (EH 3-4) com creatinina 1.5-1.9

ACLF Grau 2

- 2 insuficiências orgânicas em qualquer combinação

ACLF Grau 3

- 3 ou mais insuficiências orgânicas em qualquer combinação



Fenótipos Clínicos

“Disfunção” orgânica X “Insuficiência” orgânica

Cerebral



HE grade I-II
(West-Haven criteria)



HE grade III-IV
(West-Haven criteria)

Kidney



Creatinine 1.5-1.9 mg/dl



Creatinine ≥ 2 mg/dl



Need for renal
replacement therapy

Organ function assessment



Organ dysfunction

Organ failure

Journal of Hepatology, August 2023. vol. 79 j
461–491



Fenótipos Clínicos

“Disfunção” orgânica X “Insuficiência” orgânica

Respiration



$\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 200$

or



$\text{SpO}_2/\text{FiO}_2 \leq 214$

Circulation



Need for vasopressor

Liver



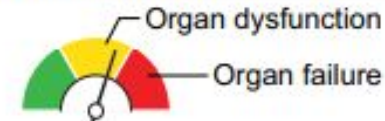
Bilirubin ≥ 12.0 mg/dl

Coagulation



INR ≥ 2.5

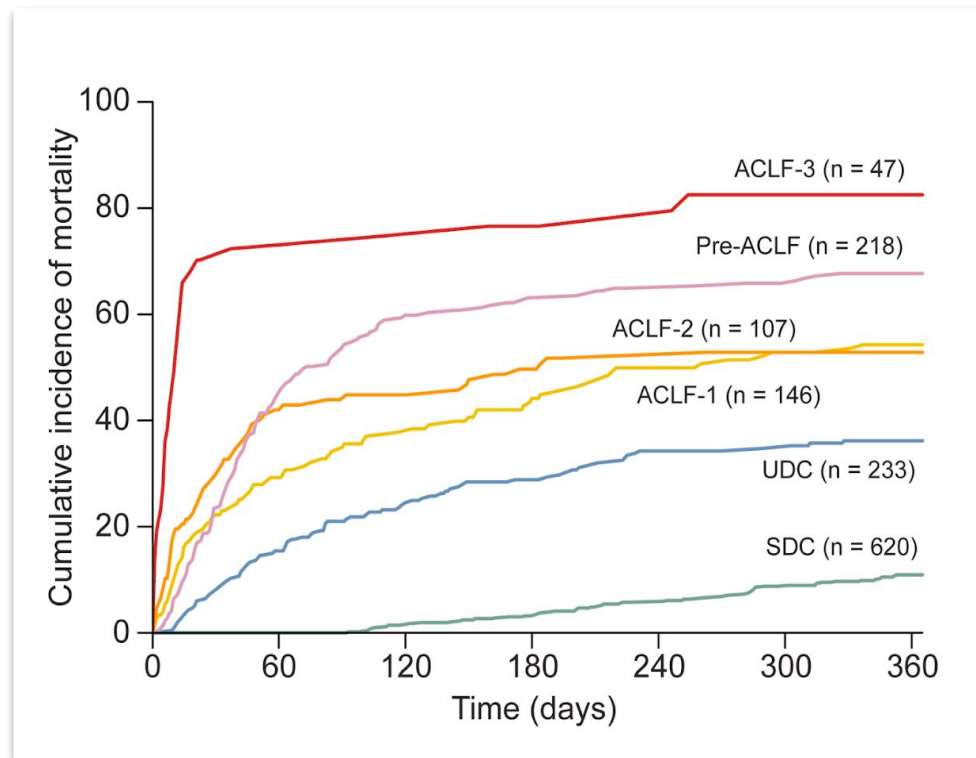
Organ function assessment



Journal of Hepatology, August 2023. vol. 79 j 461–491



Por que diferenciar?

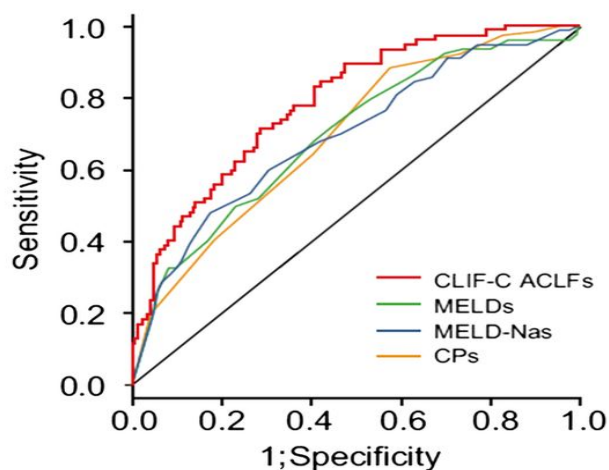


Journal of Hepatology, August 2023. vol. 79 j 461–491



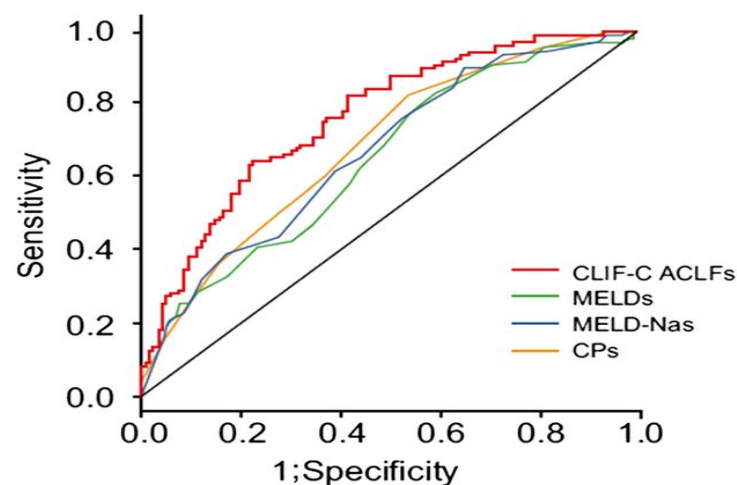
Acurácia do Score

A Prediction of 28-day mortality



		AUROC (95% CI)	p value; vs; CLIF-C ACLF
—	CLIF-C ACLFs	0.79 (0.73–0.85)	
—	MELDs	0.70 (0.62–0.77)	0.0089
—	MELD-Nas	0.70 (0.62–0.77)	0.0097
—	CPs	0.70 (0.63–0.77)	0.0075

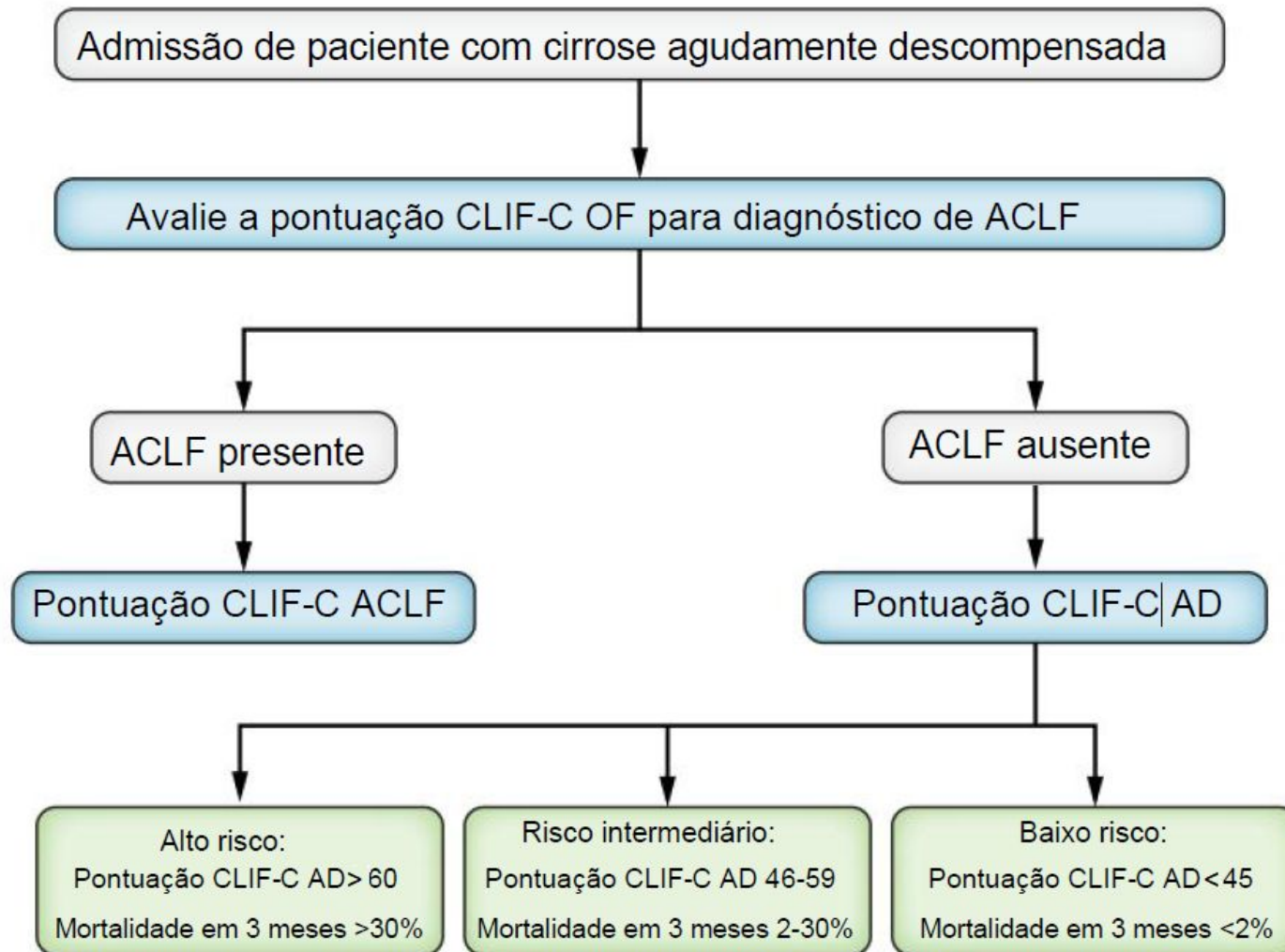
B Prediction of 90-day mortality



		AUROC (95% CI)	p value; vs; CLIF-C ACLF
—	CLIF-C ACLFs	0.76 (0.70–0.83)	
—	MELDs	0.65 (0.58–0.72)	0.0014
—	MELD-Nas	0.67 (0.60–0.74)	0.0082
—	CPs	0.69 (0.62–0.75)	0.0301

Jalan et al. J Hepatol 2014;61:1038–47



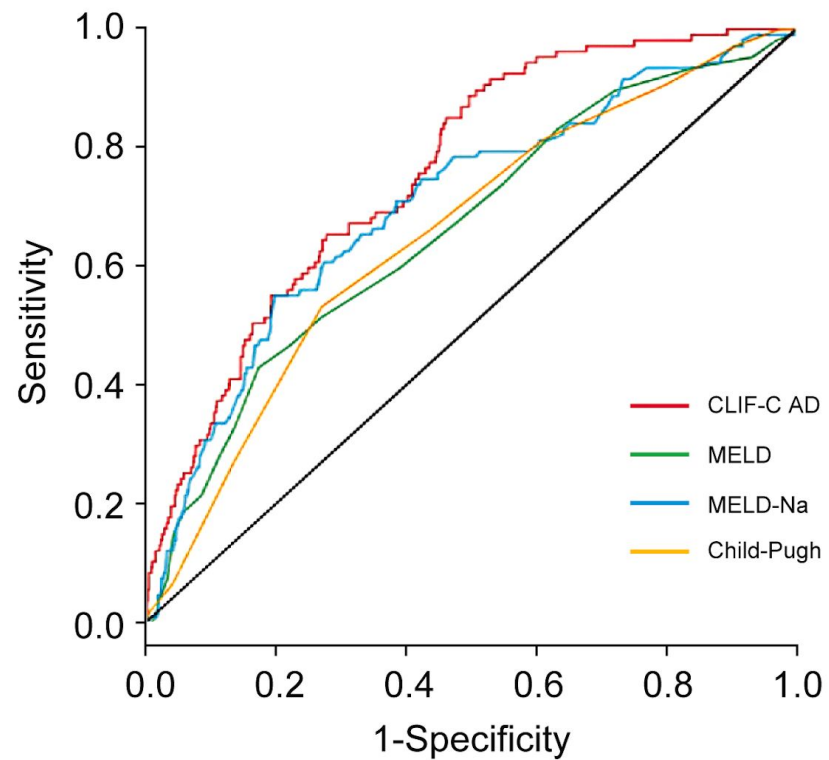


Journal of Hepatology, August 2023. vol. 79 j 461–491





DATA		CLIF-C AD Score and probability of dying	
Age	60 years		
White-cell count	7 10 ⁹ cells/L		
Creatinine	1.5 mg/dl		
INR	2.5		
Sodium (Na)	135 mmol/L		
		CLIF-C AD Score	66
		Probability of dying at 1 month	14 %
		Probability of dying at 3 month	35 %
		Probability of dying at 6 month	46 %
		Probability of dying at 12 month	58 %
RESET		COMPUTE	



		AUROC (95% CI)	<i>p</i> value vs. CLIF-C ADs
—	CLIF-C AD	0.76 (0.71-0.80)	
—	MELD	0.66 (0.60-0.72)	0.0007
—	MELD-Na	0.70 (0.65-0.76)	0.0245
—	Child-Pugh	0.65 (0.60-0.71)	0.0004

Journal of Hepatology,
August 2023. vol. 79 j
461–491



Princípios Gerais

- **Manejo de Descompensações Agudas:** controle etiológico - interrupção de sangramento varicoso, antibioticoterapia
- **Suporte orgânico:** controle de encefalopatia, rastreio de PBE, coloides/vasopressores/TRS para disfunção renal
- **Avaliação de Elegibilidade a TH:** identificar pacientes com perfil compatível com menor mortalidade esperada
- **Acessar prognóstico D3-7:** definir conforme valores do paciente/famíliares e equipe multi teto de suporte orgânico nos casos com contraindicações a transplante e evolução desfavorável



Onde o paciente deve ficar internado?

- ACLF grau 1 – monitorização de sinais vitais – semi (?)
- ACLF ≥ 2 normalmente necessita de algum suporte orgânico – UTI



Critérios de Priorização em Terapia Intensiva

Indicações UTI

- Necessidade de suporte (vasopressores, ventilação mecânica ou insuficiência renalTerapia de reposição)
- Sangramento maciço
- Encefalopatia hepática grau III-IV (proteção das vias aéreas)
- Choque séptico

Contra-indicações para internação na UTI

- Comorbidades associadas a um prognóstico muito ruim
- Pacientes fisiologicamente e/ou biologicamente com sinais de senilidade
- Pulmonar grave (critérios GOLD 3 ou 4), cardíaco (classe funcional da NYHAIII ou IV) ou doença neurológica e ACLF-3
- Neoplasia avançada (expectativa de vida <6 meses)
- Fragilidade grave secundária à sarcopenia grave (perda muscular edesnutrição) ou um status de desempenho de Karnofsky de 40 ou menos



Pesquisa de Precipitantes (EASL)

Pesquisa por consumo de álcool (frequência e quantidade)

Avaliar sintomas localizatórios de infecção e febre

Avaliar exteriorizações sanguíneas

Drogas causadoras de Encefalopatia Hepática ou Injúria Renal

Hemograma, creatinina, eletrólitos, AST, ALT, Fosfatase Alcalina, GamaGT, Bilirrubinas Totais e Frações

HCV RNA, HBsAg, DNA HBV, HEV RNA

Paracentese diagnóstica

Radiografia de tórax

Sumário de urina

Culturas de sangue, urina, líquido ascítico, fezes

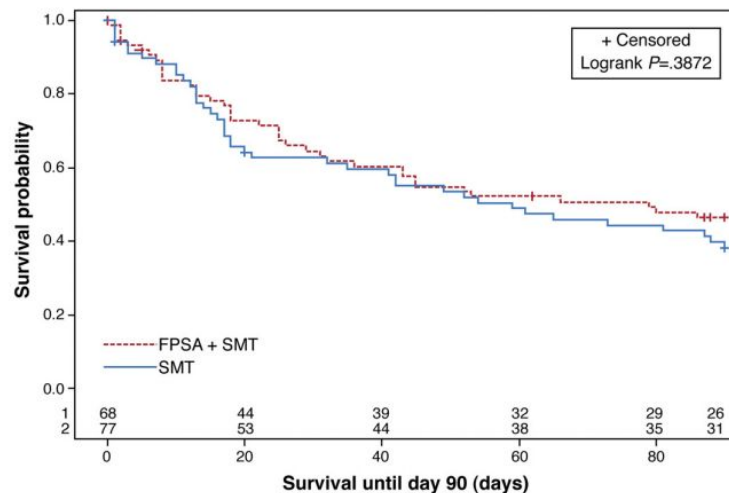
Ultrassom abdominal, hepático e renal



Suporte Extracorpóreo – MARS / PROMETHEUS

Effects of Fractionated Plasma Separation and Adsorption on Survival in Patients With Acute-on-Chronic Liver Failure

ANDREAS KRIBBEN,* GUIDO GERKEN,† SEBASTIAN HAAG,† STEFAN HERGET-ROSENTHAL,* ULRICH TREICHEL,† CHRISTOPH BETZ,§ CHRISTOPH SARRAZIN,|| ERIC HOSTE,|| HANS VAN VLIERBERGHE,|| ÀNGELS ESCORSELL,† CARSTEN HAER,†† OLIVER SCHREINER,†† PETER R. GALLE,†† ELENA MANCINI,§§ PAOLO CARACENI,||| CONSTANTINE J. KARVELLAS,||| HERMANN SALMHOFFER,†† MLADEN KNOTEK,*** PERE GINÈS,† JUSTYNA KOZIK-JAROMIN,†† KINAN RIFAI,§§§ and the HELIOS Study Group§§§



Gastroenterology. 2012 Apr;142(4):782-789.e3

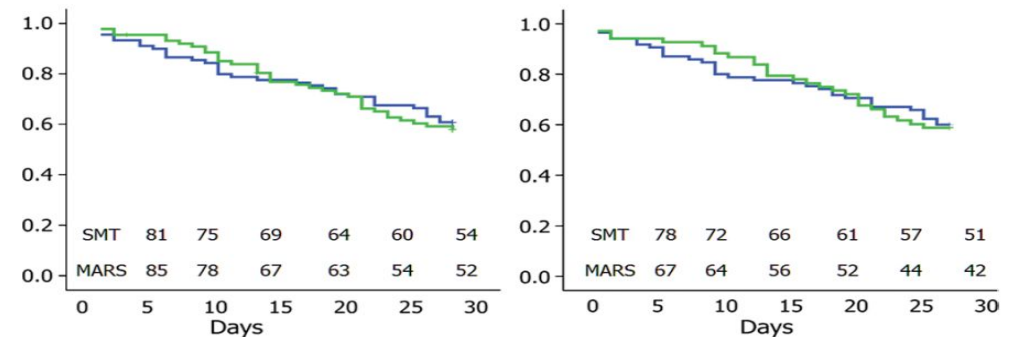
HEPATOLOGY

Official Journal of the American Association for the Study of Liver Diseases



Extracorporeal Albumin Dialysis With the Molecular Adsorbent Recirculating System in Acute-on-Chronic Liver Failure: The RELIEF Trial

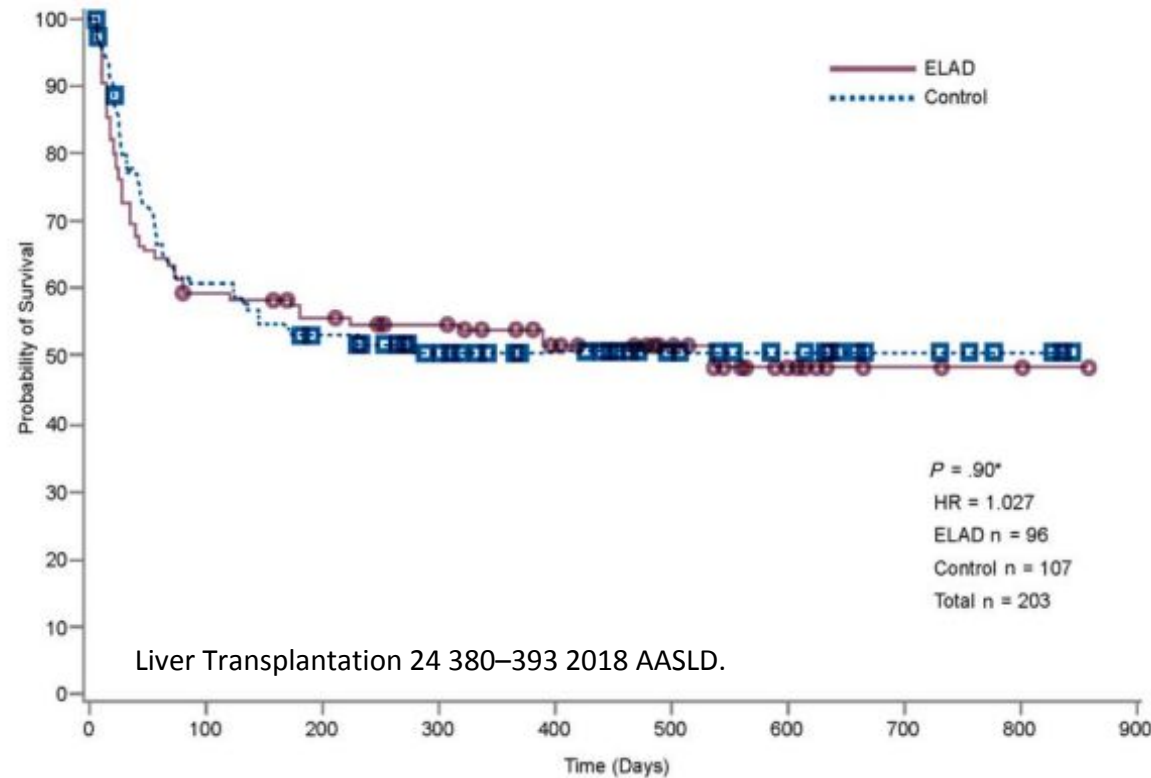
Rafael Bañares,^{1,2,3} Frederik Nevens,⁴ Finn Støtze Larsen,⁵ Rajiv Jalan,⁶ Agustín Albillos,^{3,7,8} Matthias Dollinger,⁹



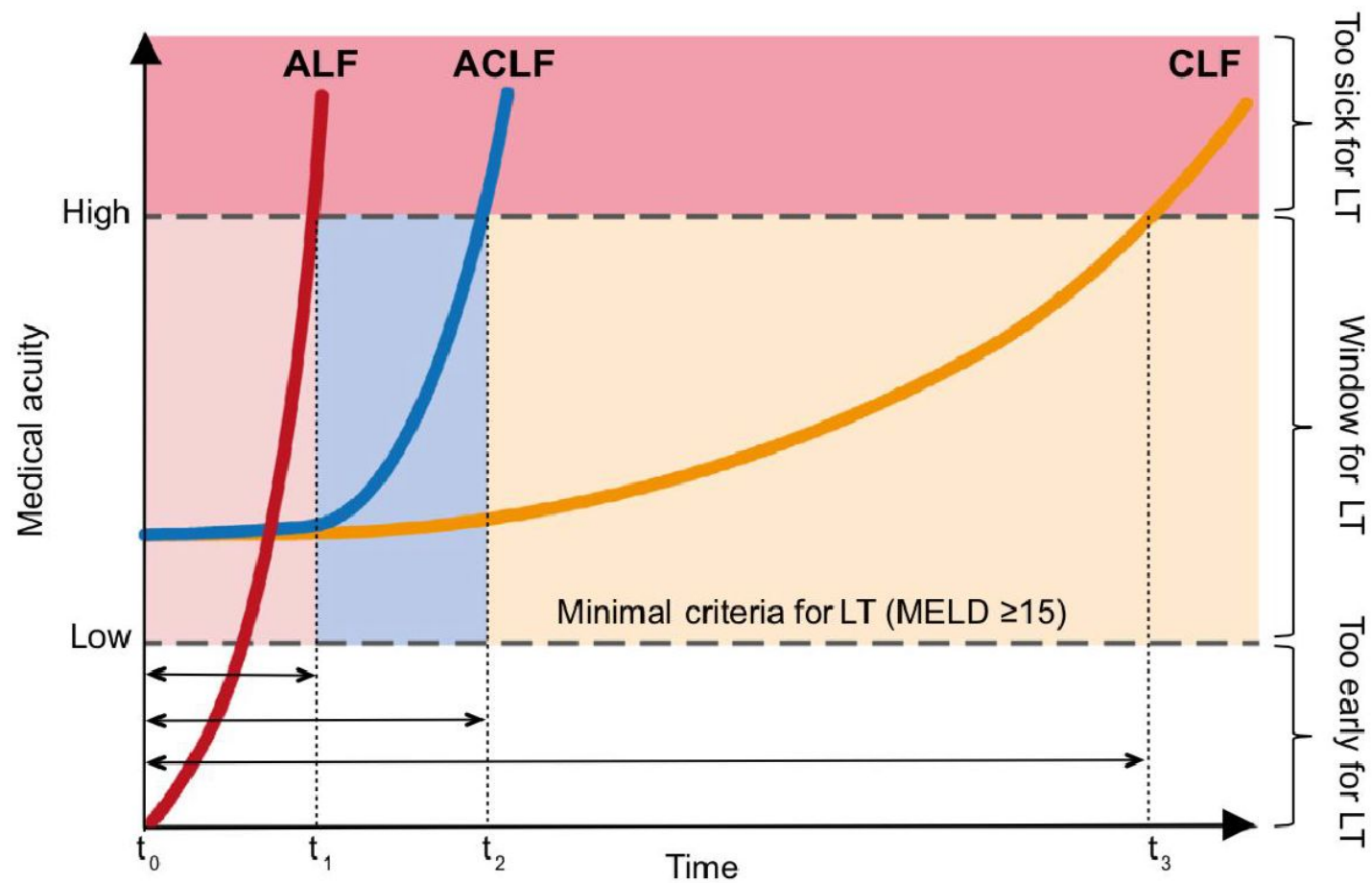
Hepatology. 2013 Mar;57(3):1153-62



Extracorporeal Cellular Therapy (ELAD) in Severe Alcoholic Hepatitis: A Multinational, Prospective, Controlled, Randomized Trial



Elegibilidad para transplante

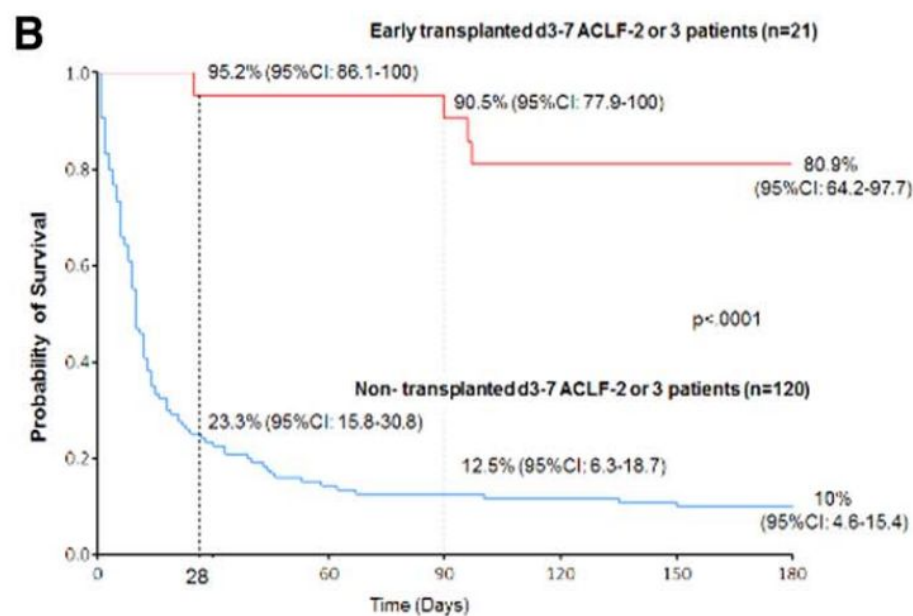
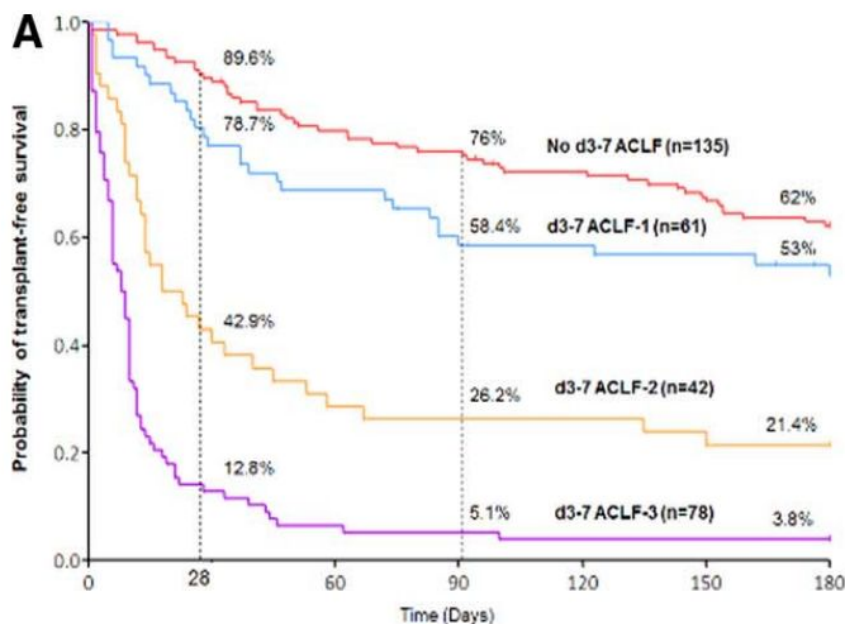


J Hepatol. 2018;68(4):798-813.



Impacto do Transplante Hepático

Uma avaliação precoce para transplante de fígado deve ser proposto para todos os pacientes com ACLF grave (ACLF-2 ou -3)

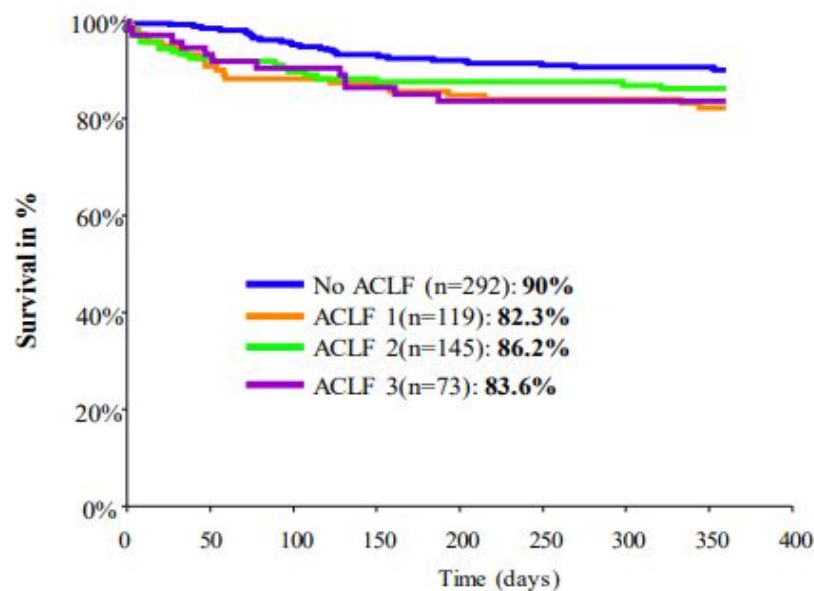
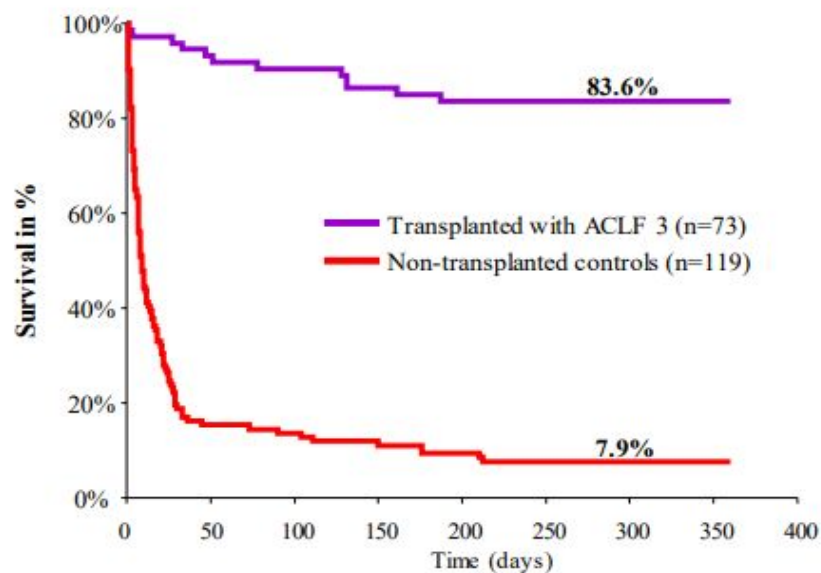


HEPATOLOGY, Vol. 62, No. 1, 2015



Impacto do Transplante Hepático

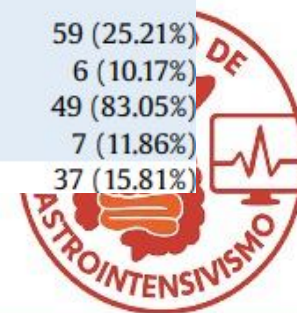
73 pacientes em 3 centros franceses que receberam TH após ACLF-3



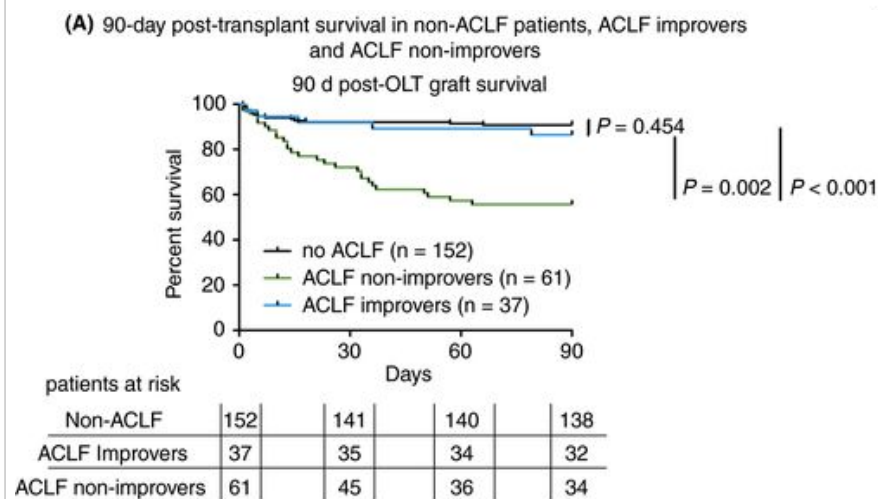
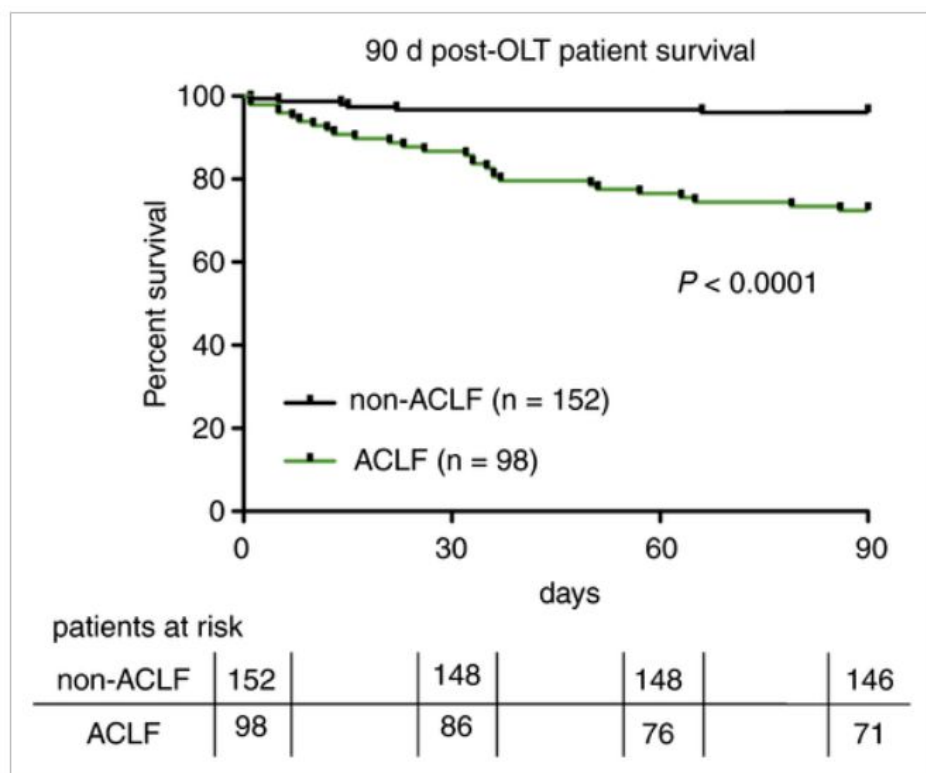
Eventos Adversos Pós TH

	ACLF at LT			Total (N = 234)
	1 (n = 58)	2 (n = 78)	3 (n = 98)	
Intubation >48 hr ^{bc} , N of pts (%)	10 (17.24%)	18 (23.08%)	44 (44.90%)	72 (30.77%)
Days of intubation				
Median (Q1-Q3)	7.0 (3.0–15.0)	6.0 (4.0–12.0)	9.5 (4.0–23.0)	8.0 (4.0–20.0)
Missing (%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	2 (2.04%)	2 (0.85%)
RRT ^{bc} , N of pts (%)	15 (25.86%)	18 (23.08%)	46 (46.94%)	79 (33.76%)
Days of RRT				
Median (Q1-Q3)	8.0 (3.0–22.0)	13.0 (6.0–19.0)	11.0 (4.0–24.0)	11.0 (4.0–22.0)
Missing (%)	2 (3.45%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	2 (0.85%)
Length (days) of total hospital stay after LT ^b				
Median (Q1-Q3)	24.0 (18.0–39.0)	30.0 (21.0–54.0)	37.5 (24.5–69.5)	32.0 (21.0–55.0)
Missing (%)	5 (8.62%)	6 (7.69%)	10 (10.20%)	21 (8.97%)
Length (days) of ICU stay after LT ^b				
Median (Q1-Q3)	7.5 (5.0–13.0)	10.0 (6.0–17.0)	12.5 (7.0–29.0)	11.0 (6.0–20.0)
Missing (%)	2 (3.45%)	3 (3.85%)	2 (2.04%)	7 (2.99%)
Post-LT MDRO infections				
Yes	14 (24.14%)	15 (19.23%)	30 (30.61%)	59 (25.21%)
Gram positive	3 (21.43%)	2 (13.33%)	1 (3.33%)	6 (10.17%)
Gram negative	11 (78.57%)	10 (66.67%)	28 (93.33%)	49 (83.05%)
Other	1 (7.14%)	3 (20.00%)	3 (10.00%)	7 (11.86%)
Death	6 (10.34%)	12 (15.38%)	19 (19.39%)	37 (15.81%)

J Hepatol 2017 Oct;67(4):708–715.



Que subgrupo pode se beneficiar?



(B) Multivariate analysis for 90-day graft survival

	hazard ratio (HR) for death or re-OLT after 90 d (95% confidence interval)	P-value
ACLF without improvement	4.147 (1.584-10.858)	0.004
Age (y)	0.963 (0.923-1.006)	0.092
CLIFc-ACLFs at ACLF diagnosis	1.018 (0.980-1.058)	0.366

Aliment Pharmacol Ther.
2018;47(11):1502-10.



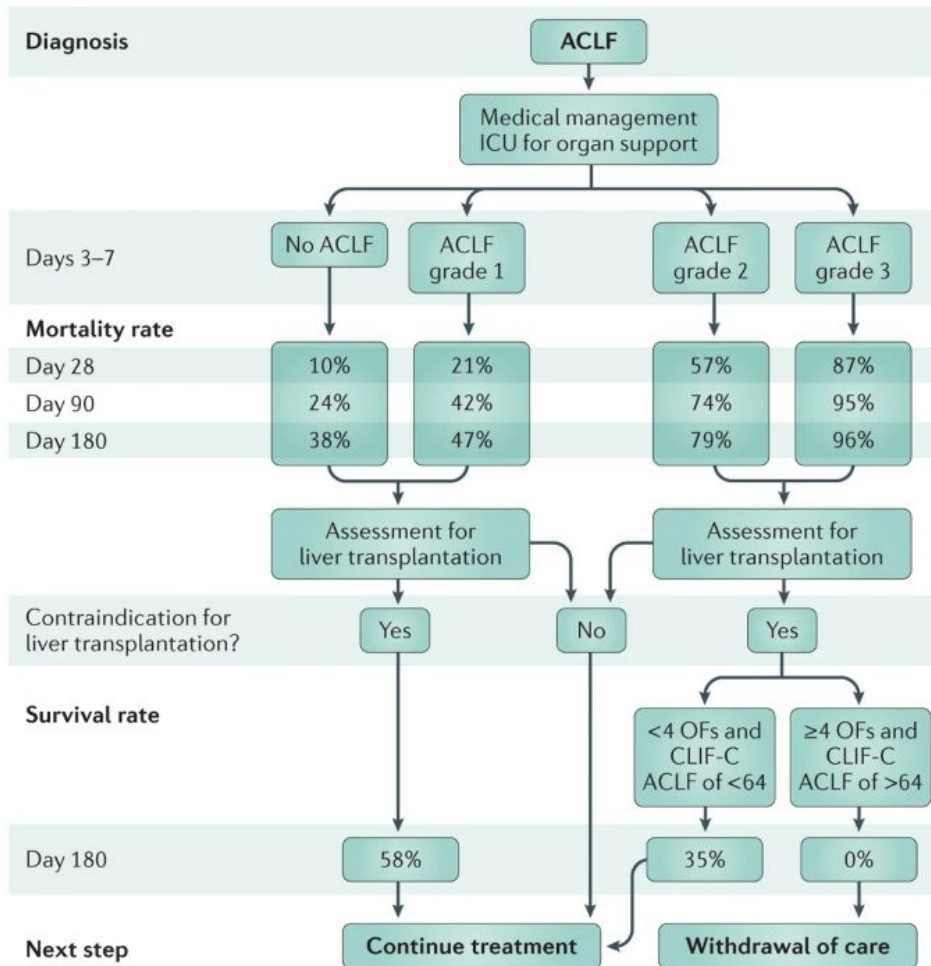
Que subgrupo pode se beneficiar?

(A) Univariate analysis of parameters affecting 90 d post-transplant survival		
	Hazard ratio (HR; 95% CI) for death after 90 d	P value
ACLF-OLT	7.839 (3.235-18.994)	<0.0001
Gender	0.740 (0.334-1.641)	0.459
Age (y)	1.026 (0.989-1.066)	0.174
Cirrhosis aetiology (alcohol/viral/others)	0.784 (0.520-1.182)	0.245
Hepatocellular carcinoma	0.685 (0.319-1.475)	0.334
Charlson comorbidity index	1.177 (0.984-1.409)	0.075
MELD score at OLT	1.074 (1.040-1.109)	<0.0001
Haemodialysis prior to OLT	4.233 (2.131-8.409)	<0.0001
Intensive care unit prior to OLT	5.633 (2.841-11.168)	<0.0001
Vasopressors prior to OLT	6.661 (3.350-13.243)	<0.0001
Mechanical ventilation prior to OLT	3.691 (1.601-8.510)	0.002
Evidence for infection prior to OLT	5.593 (2.749-11.380)	<0.0001

Aliment Pharmacol Ther.
2018;47(11):1502-10.



Algoritmo para Definição de Plano de Cuidados



Acute-on-chronic liver failure in cirrhosis. Nature Reviews Disease Primers. 2016;2(1):16041.



No. of OFs at 3-7 Days	28-Day Tx-Free Mortality (%; 95% CI)	90-Day Tx-Free Mortality (%; 95% CI)
0	1/7 (14.3; 2.6-51.3)	1/7 (14.3; 2.6-51.3)
1	0/7 (0%)	1/7 (14.3; 2.6-51.3)
2	7/12 (58.3; 32.0-80.7)	9/11 (81.8; 52.3-94.9)
3	9/17 (52.9; 31.0-73.8)	13/17 (76.5; 52.7-90.4)
4	9/10 (90.0; 59.6-98.2)	10/10 (100; 72.3-100)
5	10/10 (100; 72.3-100)	10/10 (100; 72.3-100)
6	5/5 (100; 56.6-100)	5/5 (100; 56.6-100)
Total	41/68 (60.3; 48.4-71.1)	49/67 (73.1; 61.5-82.3)

Gustot T et al. Hepatology. 2015;62(1):243-52.



Retornando ao caso do PH...

Evoluiu com necessidade de TRS

(Disfunção renal)

INR 4

(Disfunção hematológica)

BT 15

(Disfunção Hepática)

IOT-VM sem sedanalgesia ECG 6T

(Disfunção neurológica)

Mantido noradrenalina 0.4 mcg/kg/min

(Disfunção hemodinâmica)

Não recorreu a sangramentos, sem nova queda de Hb

Rastreio infeccioso negativo, em uso de Meropenem

(etiologia controlada)

Variables	Data	CLIF-C OF sub-score
Bilirubin	15 mg/dL	Liver score 3 Liver failure ☐ Yes ☒ No
Creatinine	2.5 mg/dL	Kidney score 3 Kidney failure ☐ Yes ☒ No
Renal replacement therapy	☒ Yes ☐ No	
West-Haven grade for hepatic encephalopathy (HE)	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4	Brain score 3 Brain failure ☐ Yes ☒ No
International normalized ratio (INR)	4	Coagulation score 3 Coagulation failure ☐ Yes ☒ No
Mean arterial pressure (MAP)	65 mmHg	Circulatory score 3 Circulatory failure ☐ Yes ☒ No
Use of vasopressors (circulatory failure indication)	☒ Yes ☐ No	
Select one: ☐ PaO ₂ (preferred) ☒ SpO ₂	100 mmHg %	Respiratory score 1 Respiratory failure ☐ Yes ☒ No
FiO ₂	30 %	
Mechanical ventilation (respiratory failure indication)	☒ Yes ☐ No	
Reason for mechanical ventilation	Brain failure	
https://www.efclif.com/scientific-activity/score-calculators/clif-c-aclf		Total no. of organ failures 5 CLIF-C OF score 18 ACLF grade ACLF-3
Reset		Calculate



Variables	Data	CLIF-C ACLF score and probability of death
Age	50 years	
White blood cell count	12 10^9 cells/L	
		CLIF-C ACLF score 68
		1-month mortality 86 %
		3-month mortality 95 %
		6-month mortality 96 %
		12-month mortality 97 %
Reset Calculate		

<https://www.efclif.com/scientific-activity/score-calculators/clif-c-aclf>



Mensagens Finais

- ACLF emergiu como uma das principais causas de mortalidade em pacientes com cirrose e doença hepática crônica em todo o mundo
- A prevenção dos principais fatores precipitantes, como infecções e álcool, é fundamental para melhorar o prognóstico de falências de órgãos individuais
- Gerenciamento de cuidados intensivos e listagem para TH devem se equilibrar com considerações de futilidade em pacientes com mau prognóstico
- Ainda existem aspectos da condição pouco elucidados, com trials em andamento para avaliação do impacto de intervenções



Obrigado!

Dúvidas?

Encaminhar para
gastrointensiva@gmail.com

